

✏ 침구의학 SUMMARY 공지사항

- 시험문제는 주로 질환 비교나 치료법(치료혈) 위주인 거 같음
- 회색 설명은 딱히 중요하진 않음

✏ 침구의학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: 회색
- 가출: 빨간색

▶ 오늘의 진도

[제 2장. 심혈관계 질환]

· 제 1절. 흉통(심통, 흉비, 결흉)

1. 개요
2. 서양의학적 이해
3. 한의학적 고찰

* 진단을 잘하는 방법(수업 전 첨언)

- 1) 질환과 환자에 대해 정확하게, 널리 알기
 - 2) 질병의 근본적인 원인을 찾아서 해결하기 위해 노력하기(심리적인 요인)
- 침 시술은 치료에 활용할 수 있는 것 뿐만 아니라 진단에도 활용할 수 있다.

제 2장. 심혈관계 질환

제 1절.胸痛흉통(心痛심통, 胸痞흉비, 結胸결흉)

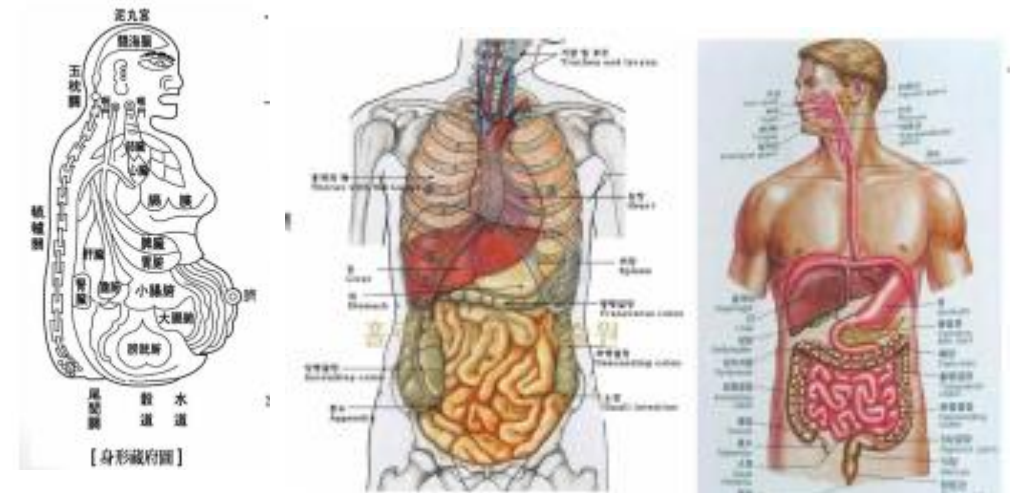
1. 개요

1) 胸이란?

- 胸: 호흡과 음식이 경과하는 부위 / 사기가 흉중에 교합되면 凶(흉할 흉)하므로 胸
- 가슴막(흉막, pleura) = 隔 - 폐를 둘러싸고 있어 背배, 胸흉, 腹복과의 경계를 이룬 막
- 胸: 심폐의 분야
- 胸腹: 장부의 외곽
- 膻中단중: 心主심주의 宮城궁성
- 胃脘위완: 咽인 하부. 가슴막을 관통하여 폐계와 상병(相竝)해서 뒤에 위치 (폐계의 뒤로 나란히 위치) = 현대의 '식도'에 가까움
- 상부는 咽門인문, 하부는 위의 상구(上口)로 들문(분문, cardia)

→ cf. 위의 하구(下口): 날문(유문, pylorus)

- 가로막(횡격막, diaphragm): 가슴막 아래로 상접한 사이에 만지(漫脂)가 서로 싸고 있는 것(기름이 넓게 싸고 있음)
- +) 신형장부도: 사람이 살아있는 그림을 그림 cf. 서양의학 해부학:
죽은 사람 - 또한 호흡이 아니라 복식호흡을 하고 있음
- +) 흉곽에 생각보다 많은 장기/장부가 있음 ⇒ 가슴이 아픔 = 무조건 심장문제라고 생각 X: 폐, 심장, 근골격계, 신경, 식도, 췌장/담낭 (흉곽 외) 등



여러 막으로 싸인 모습이 보이는데, 이는 장부간의 연결을 표현한 것이다.

서양의학의 명치부위 복통도 포함하며, 심장의 통증인지, 소화기의 통증인지 구분할 필요가 있다.

2) 흉통이란?

(1) 흉통이란?

- 흉부에 발생하는 자각적인 동통
- 주로 심장, 허파(폐 lung), 식도 및 가슴우리(흉곽, thorax) 전체 부위뿐만 아니라 가슴우리를 이루는 근육이나 골격, 견항배부, 상복부 등에도 발생 가능

(2) 한의학적 흉통

- 흉통의 범주: 심통, 흉비(胸痞), 흉비(胸痺), 결흉, 흉협통, 위완통 등
- 心痛: 실제로 대부분 음식상/담음으로 인한 위완의 통증

- 한의학의 흉통: 서양의학의 명치부위 복통(epigastric pain)을 포함
- 경과 중 허실이 대부분 섞여서 나타나고, 중노년의 몸이 쇠약할 때 나타남
- ⇒ ∴ 본허표실(本虛標實)이 주요병기

(3) 胸痞痞비

- 태음습토(太陰濕土)의 습기가 심하를 응색(壅塞), 또는 상한병에 오하(誤下)하여 한습이 심하에 침입하여 발생 / 흉격이 비만(痞滿)하되 불통한 경증

(4) 結胸結痞

- 상한병이 양(陽)에서 발한 것을 오하(誤下)하여 열이 심입(深入) / 흉격이 비색(痞塞) 하며 흉통철배(胸痛徹背)하고, 배통철흉(背痛徹胸)한 중증
- +) 흉비 vs. 결흉(더 중증) - 흉비: 음식상, 식도·위관 관련 질병이 많음 - 결흉: 흉통이 등까지 오고, 등의 통증이 가슴까지 오는 것(‘흉통철배, 배통철흉’) → 심장질환과 관련

2. 서양의학적 이해

1) 광의/협의의 흉통

[11, 12, 13, 15] 흉통에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

(1) 광의의 흉통: 심장 이외의 병변으로 유발

- 9종/6종심통, 위관통, 심비통(心脾痛), 심복통, 위관당심이통(胃脘當心而痛), 흉협통
- 가슴우리, 호흡기계, 척수, 식도와 위장, 간·쓸개(담낭)·이자(췌장) 질환이 있는 경우
- +) 간·쓸개·이자: 흉곽에 들어있진 않지만 가까이 있기에 영향을 줌
- 세부 질환: 식도역류, 식도경련, 궤양성질환, 췌장염, 담낭염, 폐렴, 폐색전증, 기흉, 늑막염, 근육통, 경추디스크, 흉막염, 늑골염, 헤르페스 등

(2) 협의의 흉통: 심장 자체의 병변에 의해 유발

- 칠정내상, 노역내상, 구병 등으로 심장의 음양기혈이 편허(偏虛)하거나 / 한응, 열결, 담조, 기체, 혈어 등의 원인이 심장에 영향을 미쳐 발생
- 관상동맥죽상경화로 인한 협심증, 급성 심근경색증, 판막이상으로 인한 대동맥판협착 폐쇄부전, 승모판협착/승모판탈출증, 폐동맥판협착증, 심장확장, 심장비대, 비후성 심근병증, 심낭염, 박리성 대동맥류 등의 질환이 있는 경우
- 최근 심장성 흉통은 물론 스트레스, 근골격계 이상으로 인한 흉통 호소 증가
- 연소화(年少化)하는 경향(젊은 사람들에게도 흉통 많이 생김)

2) 흉통을 유발하는 질환들 (회색: "읽어보세요"하고 넘어감)

- (1) 심장: 협심증(안정협심증, 불안정협심증), 심근경색, 대동맥박리
- (2) 폐: 폐동맥색전증, 기흉

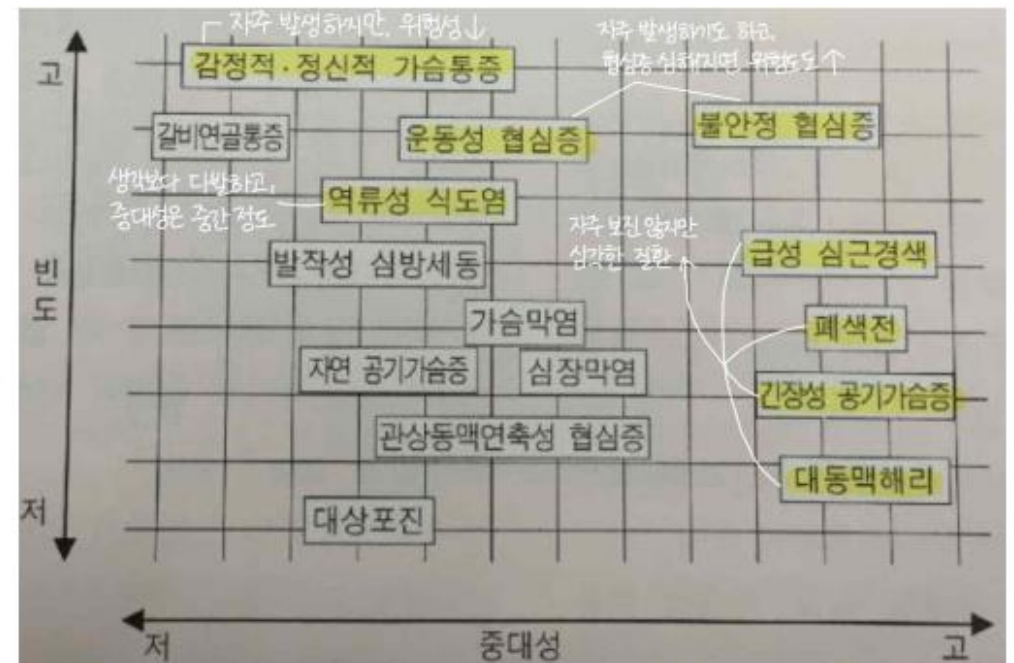
(3) 식도: 역류성식도염, 약물/칸디다 식도염, 식도이완불능증, 식도경련(미만성 식도경련), 넛크래커 식도

4) 근골격계: Isolated MS(늑연골염, 하부늑골증후군, Tietze's syndrome, Sternalis synd), 류마티스성 질환(섬유근통증후군(많지 X), RA, AS 등), 경추질환, 기타 골절, 대상포진, 종양 등

· +) 흉추 디스크로 인한 수도 있지만 늑골골절, 늑간근 염좌, 연골 염증, 늑간신경통, 대상포진 등 많음

· 외래에서 마주치는 흉통의 50% 이상이 근골격계, 소화기계(10-20%), 심혈관계 (16%), 호흡기계(10%) 정신과(10%), 미분류(4%) 이다.

3) 흉통의 빈도와 중대성



심전도에 문제가 없어도 심장 질환을 완전히 배제할 수는 없다.

4) 문진: LIQ(U)OR AAA

- 환자의 증상에 관해서 충분히 청취하기 위한 핵심용어: 술을 의미하는 liquor와 같은 스펠링(U)에 해당하는 단어만 없음
- L: location(부위)
 - +) 장부에서 오는 통증 vs. 체성으로 오는 통증
 - 심장-폐(실질 장기): 통각을 수용하는 신경들이 그리 많지 않음 ⇒ 실제 장부의 통증: 둔하게, 부위를 가리킬 수 없게 나타나는 경우가 많음
 - 흉곽·심장의 막: 통증 수용체 분포 多 ⇒ 체성 통증: 날카롭게, 부위가 명확하게 나타나는 경우가 많음 ex. 대상포진: 한쪽 방향으로 따끔따끔, 통증도 심함
 - 즉 통증 부위를 명확하게 나타낼 수 있다면 심각한 질환은 아닐 수도 있음
 - ⇒ ex. 허혈성 심질환: 가슴 전체적으로 쥐어짜는 듯하고 답답함 ⇒ 심각한
 - 장부의 통증에서 체성 통증으로 넘어가는 경우(ex. 맹장염): 초반에는 심하부쪽 묵직하고 둔한 통증 → 심해질수록 좌측 하복부 쪽 명확한 통증 → 더 심해지면 찌르는 듯한 복막염
- I: intensity(강도)
- Q: quality(성질과 상태)
 - +) ex. 계속/찌엄찌엄, 옥신옥신/쥐어짜듯이/찌르는 듯이
- O: onset(발병양식과 경과)
 - +) 언제, 어떠한 상태에서 통증이 발생하는지
- R: radiation(방산)
 - A: alleviating factor(개선 인자)
 - A: aggravating factor(악화 인자)(밥먹고 나빠지는지, 밤에 나빠지는지 등)
 - A: associated symptoms(동반 증상)
- 심각한 협심증·심근경색은 오한, 자한 등 자율신경계 증상이 동반될 수 있음
- 위 요소 중 증상에 따라 관계가 없는 것은 적당히 생략해 나가고, 감별질환을 상기시 키는 호소를 나타내는 요소에 대해서는 한층 더 심층적인 질문을 함

5) 세부 질환 - 심장성 흉통

(1) 협심증

- 일시적으로 누르는 혹은 조이는 듯한 흉통에 대한 증상명(병명 아님)
- 관상동맥의 경화로 인한 **심근허혈에서 발생하는 것**이 일반적 - +) 심근허혈의 원인 2가지: ①공급 부족 ②수요 증가 → ①공급 부족: 심장 자체에 혈액 공급 못함 ex. 관상동맥 문제로 협착이 생겨서 → ②수요 증가: 심장 부담의 증가 ex. **과도한 스트레스/운동, 발열 등 질환**
- 증상: 심부장기통으로 압박감, 묵직함, 쥐어짜는 듯한 느낌, 숨막힘 등
- 위치: 흉골의 뒤쪽, 환자가 주먹 쥔 손으로 흉골부위를 누르는 특징(Clenched fist sign)
- 기간: 지속시간은 1~15분(그리 길지 않음). 점차 증가하다 감소하는 양상
- 유발요인: **심근 산소 요구량을 높일 수 있는 상태(육체적 활동, 격한 감정의 변화, 식사, 추위에 노출, 그 외 발열, 갑상선기능항진증 등) (불안정협심증에서는 안정 시에도 일어남)**
- +) 분류 3가지: 안정형/불안정형/이형
 - 안정형 협심증: 평소엔 괜찮다가 식사 후/운동 심하게 한 후 나타남
 - 불안정형 협심증: 관상동맥의 협착이 심해지는 것. 밤에 주로 발생
 - ⇒ 산소 소모량이 늘어났을 때(ex. 운동 후)뿐 아니라 휴식 시에도 발생
 - 이형 협심증: 관상동맥 경련(협착X)이 생겨 혈액 공급이 안 돼서 생기는 것
 - ⇒ 규칙적으로 나타남
- 통증의 완화(산소 요구량 ↓): 휴식, Nitroglycerine 설하투여 (심적환을 사용해도 좋음, 양방에선 아스피린과 같은 혈전 약이나 심근 소모량을 감소시키는 약을 사용하는 경우가 많음)
- 방사 부위: 주로 왼쪽 어깨나 양팔, 특히 팔과 손의 내측면 따라 잘 방사됨. 등, 목, 턱, 배로도 방사
- +) 손의 내측면 =수소음심경의 경로
- 동반증상: 호흡곤란, 불안감, 식은땀, 심계, 오심, 현훈 +힘이 쭉 빠짐 → 자율신경계에 문제가 생기는 실조증으로 인한 증상들

(2) 심근경색

- 관상동맥 경화로 혈관 협착이 심해지거나 오래 지속되어, 심근허혈에서 진행되어 손상, 괴사에 이른 것: 심근경색 =협심증이 심해진 것 (cf. 협심증: 허혈만 있는 것)
- +) 실질적으로 심장근육의 세포가 손상된 것

[14, 17, 18] 협심증과 심근경색을 비교 대조하여 서술하시오

- **협심증과의 공통점:** 흉부 통증이 좌상지 내측 등으로 방사됨
- **협심증과의 차이점:** 협심증보다 더욱 격렬하고 지속시간이 30분 이상으로 길
- 흔히 안정 시(에도) 발생 (∴ 심해진 상태이므로)
- Nitroglycerine으로는 진통이 되지 않고 진통제(Morphine)로 감소됨
- 15-20%(주로 당뇨병 환자, 노인)에서는 통증이 안 나타나기도 함: 단순히 체한 것처럼 불편하거나/가슴이 답답한 경우에도 간혹 심근경색일 수 있음
- **동반증상:** 미주신경 자극으로 반사적인 오심, 구토, 실신 / 좌심실 부전으로 호흡곤란 - 1일이 경과되면서부터 수일간 38°C 이상의 고열이 나타나기도 함
- 급성 심근경색의 경우 30% 이상의 사망률
- **혈전용해요법:** 통증 발생(경색 발생)직후에서 1~3시간 내에 효과적. 늦어도 6시간 이내에 시행해야 함

6) 세부 질환 - 심장성 흉통 외

(1) 대동맥해리 (대동맥 박리 aortic dissection)

[18] 흉통이 나타나는 질환에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- +) =혈관이 벗겨진/찢어진 것
- **증상:** 가슴 or 등쪽에서 이동하는 통증. 강한 불에 달궈진 부엌가락에 찔린 듯한 통증
- +) 상행대동맥 손상 → 주로 가슴쪽 통증 / 하행대동맥 손상 → 등쪽(견갑골 사이)
- 갑자기 발병. 지속통임
- 다양한 합병증: 심근경색, 심장눌림증(=심장압전증), 신부전 등

(2) 긴장성 공기가슴증 (긴장성 기흉 tension pneumothorax)

- 폐에 구멍이 생겨 흉강 내에서 공기가 새어나와 폐가 자체의 탄력으로 위축되는 질환
- +) 폐: 탄성이 강함 → 음압(대기압보다 압력 ↓)으로 퍼져 있음(음압으로 유지됨)
- 구멍이 뚫리면 공기가 한쪽으로부터 통할 수 있어 자유롭게 이동을 못함(빛금 부분 (가슴막 공간)으로 들어가기만 하고 나오질 못함 =환기가 안 됨) → 음압이 없어짐 (대기압과 같아짐) → 폐가 쪼그라들 → 호흡을 못함
- ⇒ ∴ 치료: 공기를 밖으로 빼줌
- ⇒ ex. 흉관천자: 구멍을 뚫어서 공기를 내보내줌
- 공기가 안 통하니까 점점 쪼그라들 (그래서 급증)



- **기전:** 구멍이 한쪽으로부터 공기를 흐르게 하는 판막모양일 때 들숨 때는 공기가 흉강 내로 들어와도 날숨 때 나가지 않음 → 흉강 내에 공기가 저류됨 → 폐는 환기를 할수 없게 되고, 양압에 의해 혈관이 눌러 정맥역류, 심박출량 ↓

· 특징

- 통증은 한쪽에서 비교적 강하게 나타남: ∴ 기흉 발생 부위에서 통증이 생기므로
- 갑자기 발병하거나 서서히 발병해서 악화되며, 서서히 증상이 강해짐
- **호흡할 때마다 악화됨:** ∴ 숨을 마실 때마다 공기가 저류되므로
- **동반증상:** 호흡곤란, 두근거림, 불안감, 기침 등
- +) 긴장성 기흉: 외상성(ex. 사고로 갈비뼈가 부러져 찢림), 급증임
- cf. 의인성 기흉: 내시경, 치료 등으로 인해 잘못 찢려서 생김
- cf. 자연성 기흉: 아무것도 하지 않았는데 생김. 호흡할 때마다 악화되고, 기침나고, 흉통이 생김. 주로 마른 사람(폐가 탄력성이 떨어질 것 같은 사람)에게 생김.

(3) 폐색전증 (pulmonary embolism)

- 정맥 혈전 등이 혈류를 타고 폐동맥으로 흘러 들어가 막히는 질환
- 저산소혈증, 폐경색 등 유발
- +) 경색: 허혈이 심해져서 손상/괴사가 일어나는 것
- **증상:** 기관지 점막의 출혈로 인한 혈담, 흉막 자극으로 인한 흉통 나타남
- **특징**

- 통증은 한쪽에서, 지속적으로 나타남

- 갑자기 발병함

- **동반증상:** 호흡곤란, 빈맥, 빈호흡, 기침, 혈담 등 동반

(4) 식도파열 (esophageal rupture)

- 구토, 내시경 등으로 인해 식도벽이 파열되는 질환
- +) 과음하고 구토를 심하게 하다 오는 경우도 드물지만 있음
- TT
- 식도 내부는 아직 위액에 의해 소독되지 않아 더러우며, 식도 주위는 결합조직으로 둘러싸여 있어 혈류가 적고 감염 시 쉽게 확산되어 치료가 어려움(세로칸염(중격동염)(mediastinitis), 가슴막염(pleuritis) 등 일으킴)

- 갑자기 발생 (급증)

· **증상:** 두들겨 맞은 듯한 흉통, 명치부분 쓰리고 아픈 상복부통

· **동반증상:** 출혈이 있으므로 ⇒ 발열, 피하기증, 혈압저하 등을 동반

· +) (1)~(4): 급증, 심한 질환

(5) 호흡기 질환에서의 흉통

· 갑작스러운 증상 발생 → 폐경색증, 자연공기가슴증 등

· 침으로 찌르는 듯한 통증 → 흉막염

· 지속적인 둔통(→실제 장기의 통증) → 폐렴, 폐농양, 폐암

└ 흉벽의 피부, 근육, 뼈, 벽쪽가슴막 등: 통각신경 분포가 발달 ⇒ 통증 ↑

└ 폐: 실질장기로 통증에 민감X ⇒ 폐렴 등 염증이 흉막으로 미치거나 종창에 의해 └ 흉막으로 진전되면 통증이 발생

7) 심근경색과의 감별 진단

· **심낭염:** 호흡/자세에 따라 통증 변화함

· **흉막염:** 흡기 시 통증 증가

· **박리성 대동맥류:** 통증이 등으로 방사. 맥박 소실됨. 찢어질 듯한 심한 통증 - +) 대동맥에 문제가 생기므로 맥박 잘 안 잡힘

· **폐색전증:** 통증은 약하고, 호흡곤란과 현훈이 심함

· **식도파열:** 심한 구토가 선행되며 토혈이 있음

· **소화성 궤양의 천공:** 복부쪽이며 심전도 정상

· **담석산통:** AST, ALT 증가하나, CK는 정상. 심전도상 Q파 없음 - +) 소화가 안 되면 위·궤장을 먼저 생각하지만, 생각보다 담낭염도 소화 안 됨

· **급성췌장염:** 심한 구토 있음. AST, ALT와 함께 아밀라아제도 상승 - +) 가장 많은 원인은 알코올

· **근골격계 이상:** 호흡/체위변경 시 통증 가중됨

· **신경성 흉통:** 칼로 찌르는 듯한 통증. 대부분 좌흉부에 명확한 경계가 있고 스트레스·과도한 긴장에 노출 시 가중됨 ex. 신경에 문제가 생기는 대상포진 등

· +)

· 심장 문제 → 가슴쪽 / 견갑골 안쪽 통증

· 견갑골 안쪽: 근골격계 문제로 많이 생각하지만, 심장문제일 수 있음

· 드물지만 심장 문제로 옆구리 아래/턱 통증 나타나기도 ex. 좌협부/우협부 아래

· 좌협부 - 췌장, 우협부 - 간·담 질환인 것 같지만, 심장문제일 수 있음

3. 한의학적 고찰: 치료

1) 기본치료혈

· **주혈:** 內關·內關·心俞·心俞

- 내관: 심통에 가장 많이 사용. 심수와 같이 쓰는 경우 多 (내관이 효과 더 좋음)

→ 심포의 락혈, 심포의 가장 기본 혈

→ 상사자해서 침창(침침)이 가슴으로 가도록 함: 교수님은 직자를 더 선호

· **실증:** 間使·間使·厥陰·厥陰·豐隆·豐隆·巨闕·巨闕·郄門·郄門

· **허증:** 膈俞·膈俞·足三里·足三里·命門·命門·腎俞·腎俞

· **중증:** 關元·關元·氣海·氣海·巨闕·巨闕·人中·人中·膻中·膻中(단중)

- +) 관원·기해: 기운을 복돋는 혈 / 인중: 급증일 경우 같이 사용

· +) 흉통, 소화기계·심혈관계 질환: 임맥 혈자리 다용

- 심장 문제: 전중·거결 다용(보통 약침 같이) ← 임독맥은 약침 같이 많이 응용함

2) 변증치료

(1) 실증

① 심혈어조(心血瘀阻)

· **증상:** 胸部刺痛·胸部刺痛·固定不移·固定不移·入夜更甚·入夜更甚·입야경심·舌紫暗·舌紫暗·脈沈細·脈沈細 맥침

세 → 어혈의 특징이 많이 나타남: 통증이 고정(고정불이), 야간에 심함(입야경 심)

· **치법:** 活血祛瘀·活血祛瘀·通絡止痛·通絡止痛

· **침구처방:** 太衝·太衝·三陰交·三陰交·삼음교

② 담탁옹색(痰濁壅塞)

· **증상:** 胸悶如窒而痛·胸悶如窒而痛·홍민여질이통·或痛引肩背·或痛引肩背·홍민여질이통·氣短喘促·氣短喘促·기단천축·肢體沈重·肢體沈重 지체

- +) 홍민여질이통: 가슴이 답답/막히는 것 같으면서 통증 / 홍민여질이통: 통증이 견배로 당기는 듯함 / 기단천축: 숨 쉬는 게 짧아지고, 기도호흡이 더 빨라짐

· **치법:** 豁痰開結·豁痰開結·담개결

[18] 54세 남성이 흉부자통, 고정불이, 입야경심, 설자암, 맥침세의 증상으로 내원하였을 때 올바른 치료혈은?
[11] 43세 여성이 가슴부위의 찌르는 듯한 통증으로 내원하였다. 통증이 고정되어 이동하지 않고, 설자암, 맥침세한 경우 치료혈은?

· **침구처방:** 中脘중완·豐隆풍릉 → 담음에 다용하는 혈

③ 음한응체(陰寒凝滯)

· 증상: 胸痛徹背흉통철배 感寒痛甚감한통심 胸悶氣短흥민기단 心悸심계 重則喘息不能 平臥중즉천식불능평와

- +) **흉통철배: 통증이 등까지 감** / 감한통심: 추위에 감촉되면 통증이 심해짐 / 흥민기단: 가슴 답답, 숨 짧아짐 / 심계: 심장 두근두근 / 중즉천식불능평와: 심장 증상이 심해질수록 누워있는 게 불편해짐 (→불면 환자 중 많은 비율이 심장 약한 사람들)

→ 불면: ①정신 문제 ②호르몬 문제 ③심장(협심증 등 질환 아니더라도 심장에 문제 있을 때도: 이때는 입면장애보다 유지장애가 많음)

· **치법:** 辛溫通陽散寒신온통양산한

· **침구처방:** 大陵대릉·郛門극문·關元관원

- +) 심장질환에는 수소음심경 < 수결음심포경 → “심장 자체 흥통/답답함에는 심포 경이 더 효과가 좋았음” cf. 수소음심경: 신경정신과 쪽

[15] 62세 할아버지 흉통철배 음한통심 흥민기단 심계 중즉천식불능평와에 사용하는 혈을 고르시오.
[14] 47세 남성이 등을 꿰뚫는 듯한 가슴통증으로 내원하였다. 感寒痛心 胸悶氣短 心悸 重則喘息不能平臥한 증상이 있을 때 침구 처방으로 옳은 것은?

(2) 허증

① 심신음허(心腎陰虛)

· 증상: 胸悶且痛흥민차통 心悸盜汗심계도한 心煩不寐심번불매 腰痠膝軟요산슬연 耳鳴 이명 頭暈두혼 - +) 흥민차통: 가슴이 답답하거나 통증 / 심번불매: 불면증

· **치법:** 滋陰益腎자음익신 養心安神양심안신

· **침구처방:** 內關내관·公孫공손·三陰交삼음교·神門신문

· +) 심장이 허하다고 생각될 때, 심기허/심음허 잘 감별

- 심음허: 가슴이 열이 나는 것 같고, 두근두근, 잠 잘 못 잠

[13, 17] 53/64세 여성이 가슴 답답하고 은은한 통증 있는 증상으로 내원했다. 時作時止 心悸氣短 倦怠懶言 面色少華 頭暈目眩 怒則甚일 때 치료혈은?

② 기음양허(氣陰兩虛)

· 증상: 胸悶隱痛흥민은통 時作時止시작시지 心悸氣短심계기단 倦怠懶言권태나연 面色少華면색소화 頭暈目眩두혼목현 勞則心도즉심

- +) 흥민은통: 가슴 답답하면서 은은한 통증 / 시작시지: 때때로 시작되고, 때때로 그침 /

심계기단: 심장 두근, 숨 짧아짐 / 권태나연: (기가 허하므로) 느려짐. 말도 느려짐 / 면색소화: 얼굴색 창백 / 도즉심: 무리하면 심해짐

· **침구처방:** 郛門극문·曲澤곡택

③ 양기허쇠(陽氣虛衰)

· 증상: 胸悶氣短흥민기단 甚則胸痛徹背심즉흥통철배 心悸심계 汗出한출 畏寒외한 肢冷지냉 - +) 외한: 추위를 많이 타게 됨

· **치법:** 益氣溫陽익기온양 活血通絡활혈통락

· **침구처방:** 大陵대릉·足三里족삼리

(3) 중증

① 심양욕탈(心陽欲脫)

· 증상: 面色紫면색자 甲靑紫갑청자 大汗淋漓대한임리 四肢厥冷사지궤냉 脈微欲絶맥미 욕절

- +) 면색자: 얼굴색 자줏빛 / 갑청자: (피가 안 통하므로) 조갑 색이 바뀜 / 대한임 리: 땀이 비 오듯 흐름

· **치법:** 回陽固脫회양고탈 益心陽익심양

ππ: 氣海기해·關元관원

- +) ∴기운을 북돋기 위해 씬 ⇒ 따라서 침보단 뜸이 효과 좋을 듯

② 수기능심(水氣凌心)

· 증상: 心悸胸悶심계흥민 喘促不得臥천촉부득와 咳嗽血痰해수혈담 肢體浮腫지체부종 小便短少소변단소 舌紫暗설자암 苔白膩태백니 脈促惑疾맥촉혹질 - +) 천촉부득와: 숨이 가쁘고 쉬기 힘들고, 누울 수 없음 / 해수혈담: 피 섞인 기침

· **치법:** 祛痰化濕거담화습 清心安神청심안신

· **침구처방:** 巨闕거궤·人中인중·膻中전중

- +) 인중: 급증이므로 사용

· +) 중증에 가까울수록 구급혈, 기해, 관문 등을 많이 사용함

신장에 의한 부종은 저녁에 주로 발생하며(하체)

심장에 의한 부종은 아침이나 식사 후에 주로 발생한다.

3) 기타치료

①이침/②전침/③두침: "한 번 읽어보면 좋을 듯"

4. Tip

- 심통: 앞가슴 동통의 다양한 병증. 胸痺흉비, 眞心痛진심통, 厥心痛궤심통 등으로 나뉨
- 병이 심하면 胸痛徹背흉통철배, 背痛徹心배통철심함
- 고대에는 심통(심장질환)과 위안통(소화기질환)을 모두 심통이라 하므로 주의해 구분
- 진심통, 궤심통: 실제 심교통(心絞痛)을 가리킴 - 임상, 실험 결과 내관 자침 시 심교통에 효과 높음
- 치료 전에 세심한 진찰을 통해 위급한 병증을 배제해야 하며, 침구 치료 시에도 신중히 안전을 기해야 함

- 심장이 안좋은신 분들은 날개뼈 안쪽에 통증을 호소하는 경우가 있다.

따라서 견갑골 사이에 통증이 있는 경우에 근골격계 치료를 하다가, 치료 효과가 없으면 심장 질환을 의심할 수 있다.(우측 통증도 가능)

- 출혈부터는 다음시간에